PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN · DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA

Favorecer la respuesta intersectorial a las diferentes necesidades sociales y de atención de salud concomitantes de las personas mayores que viven en su domicilio: perfiles, cartografía de recursos y análisis de redes.



Eric Bernier, LL.M. y M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
Doctorado en salud pública · Sistemas, organizaciones y políticas de salud · ESPUM, Université de Montréal

CODIRIGIDO POR LAS
Dras. Nadia Sourial y Géraldine Layani

01 Contexto

CCSMTL: 8 territorios de CLSC, 48 575 personas de 65 años y más en 2026
ISQ, 2026

≈ 3 700
solicitudes al 211 de personas de 70 años y más, 2021-2026
211 Grand Montréal, 2026

691
necesidades no cubiertas, 60 años o más (análisis de sensibilidad)
211 Grand Montréal, 2026

TRES NOCIONES A DISTINGUIR

Personas mayores atendidas en su domicilio que acumulan necesidades sociales; una respuesta que se organiza en el territorio del CLSC.

Necesidades concomitantes

Necesidades sociales y de atención de salud presentes en las mismas personas.

Personas mayores en su domicilio

personas mayores que viven en su domicilio con necesidades sociales y de atención de salud concomitantes que pueden requerir respuesta intersectorial en atención primaria.

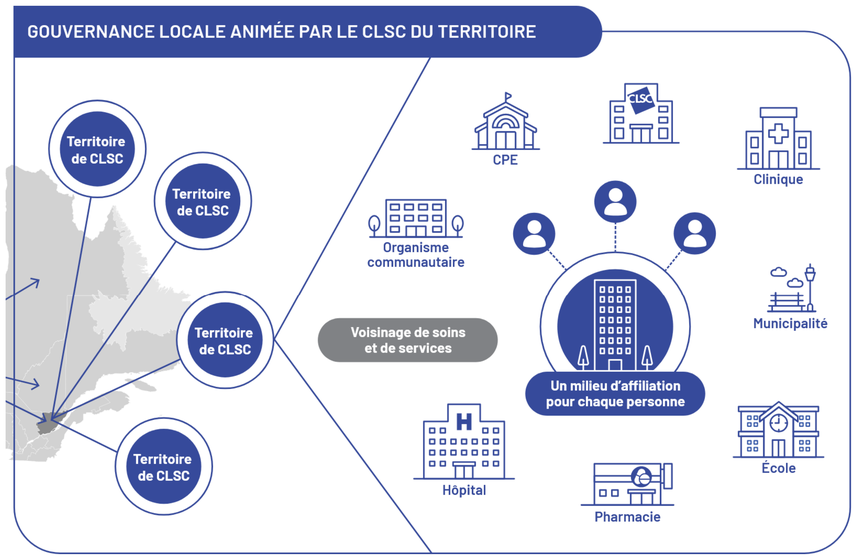
SE ORGANIZA EN UN TERRITORIO

Respuesta intersectorial

Acciones de sectores distintos de la salud, realizadas con ella, sobre la salud o sus determinantes: red pública, primera línea, parapúblico, comunidad, municipio, vivienda.
MSSS, 2017; Leppo et al., 2013

POLÍTICA DE PRIMERA LÍNEA · MSSS, 2026

El territorio de CLSC: nueva unidad de referencia



CUATRO ROLES DEL CLSC

Navegador · Coordinador · Líder intersectorial · Cofacilitador

«con un espíritu de gobernanza compartida» · MSSS, 2026, p. 42 · esquema: MSSS, 2026

¿Cómo se organiza la respuesta intersectorial a las necesidades sociales y de atención de salud concomitantes de los distintos perfiles de personas mayores que viven en su domicilio?

O1
Identificar los distintos perfiles de personas mayores que viven en su domicilio y presentan necesidades sociales y de atención de salud concomitantes que pueden requerir una respuesta intersectorial en atención primaria.

O2
Cartografiar los recursos territoriales que pueden movilizarse en atención primaria para responder a las necesidades sociales y de atención de salud concomitantes de los distintos perfiles de personas mayores que viven en su domicilio, y caracterizar las variaciones territoriales de su disponibilidad, diversidad, complementariedad y accesibilidad.

O3
Analizar las configuraciones organizativas de las redes intersectoriales en atención primaria movilizadas en el territorio para responder a las necesidades sociales y de atención de salud concomitantes de los distintos perfiles de personas mayores que viven en su domicilio, con el fin de caracterizar sus modalidades de funcionamiento.

02 Metodología propuesta

PROTOCOLO PROVISIONAL · lugares, alianzas y autorizaciones por confirmar

personas mayores que viven en su domicilio con necesidades sociales y de atención de salud concomitantes que pueden requerir respuesta intersectorial en atención primaria.

Objetivo metodológico O1

Realizar una revisión de la literatura científica para identificar y caracterizar los distintos perfiles de personas mayores que viven en su domicilio y presentan necesidades sociales y de atención de salud concomitantes que pueden requerir una respuesta intersectorial en atención primaria, y determinar las necesidades asociadas a cada uno de estos perfiles.

Revisión de alcance · 4 bases

- búsqueda sistemática, criterios explícitos y dos evaluadores independientes.
- poblaciones, contexto de atención primaria, necesidades sociales y sanitarias, definiciones, instrumentos, concurrencia individual y perfiles publicados.
- revisión de alcance JBI y reporte PRISMA-ScR; síntesis descriptiva de definiciones, necesidades asociadas y configuraciones documentadas.

Objetivo metodológico O2

Realizar un estudio cartográfico y espacial de los recursos movilizables en atención primaria para responder a las diferentes necesidades sociales y de atención de salud concomitantes asociadas a los perfiles de personas mayores que viven en su domicilio a fin de caracterizar, en los distintos territorios de CLSC, su distribución, disponibilidad, diversidad, complementariedad y accesibilidad territorial.

6 sectores · análisis ecológico

- identificación sistemática de recursos admisibles en las fuentes seleccionadas; reglas explícitas de inclusión y eliminación de duplicados.
- localización, sector, necesidades, disponibilidad documentada, acceso, admisibilidad, horarios y capacidad cuando consten.
- estudio cartográfico y espacial en R y QGIS; distribución, disponibilidad, diversidad, complementariedad y accesibilidad territorial.

Objetivo metodológico O3

Realizar un análisis retrospectivo de redes sociales (ARS) intersectoriales movilizadas en atención primaria a partir de territorios de CLSC para responder a las necesidades sociales y de atención de salud concomitantes de los diferentes perfiles de personas mayores que viven en su domicilio, para caracterizar su composición, la estructura de sus relaciones, así como la naturaleza y la intensidad de las colaboraciones entre actores.

Un cuestionario · 12 meses · redes completas y egocentradas

- un único cuestionario relacional administrado una vez sobre los últimos 12 meses.
- relaciones entre todas las organizaciones del perímetro territorial; composición, estructura y funcionamiento según la cobertura lograda.
- entorno de las organizaciones o equipos focales, incluido el CLSC; tamaño, diversidad y vínculos ego-alter. Los vínculos alter-alter requieren recogida explícita.

O1: perfiles · O2: recursos · O3: redes. ARS cuantitativa observacional retrospectiva en varios territorios de CLSC contrastados.

03 Productos esperados · sin resultados de tesis

Perfiles fundamentados + viñetas

Atlas + matriz necesidades-recursos-territorio

Redes contextualizadas + mecanismos

04 Contribución prevista

Comprender las brechas entre necesidades, oferta accesible y ayuda movilizada; discutir opciones organizativas con las personas implicadas y los actores del territorio.
Sin beneficio individual garantizado.

Contacto ≠ colaboración ≠ ayuda recibida ≠ necesidad resuelta. Las cifras del 211 y los mapas contextuales son ilustrativos; no sustituyen la recogida de datos de O3.

Brewster, Tan, & Yuan (2019). Health Services Research, 54(6), 1246-1254. doi:10.1111/1475-6773.13206 · AHRQ (2014), Care Coordination Measures Atlas, ch. 4.